

Fecha Última Actualización: 22-12-2022 9:29:49

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Carlos Matías Bravo Quinteros
Edad : 28a 4m 6d
Dirección : Av. La Viña 381

Rut : 18.880.945-6
Fecha Nacto: 09/08/1994
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0908622
Sexo : Masculino
Teléfono : 967394796

N° Epicrisis
333658

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 10/11/2022 12:05

Días Estadía: 35

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 15/12/2022 08:12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

comp de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

- AM: TEC grave en febrero 2022 operado, consultas repetidas por autoagresiones, consumo de sustancias.
- Qx: Craniectomía descompresiva derecha feb 2022, OTS antebrazo izquierdo, Drenaje en pulmón, desforramiento tobillo izquierdo. Corte con corta cartón en cuello.
- Alergias: No.
- Fcos: Uso Ac Valproico-- profiláctico según epicrisis marzo 2022, DZP y risperidona tras alta en febrero, aparentemente sin medicamentos actuales-- en evaluación pre-quirúrgica en agosto 2022 se describe sin medicamentos.
- Hábitos: éxtasis, THC, cocaína, BZP, PBC, OH.
- Social: tendría orden de alejamiento de la familia. Actualmente está en calidad de detenido por causales pendientes.

Anamnesis próxima:

Paciente encontrado a las 10/11 10:00am en la calle comprometido de consciencia y en apnea, por lo que es trasladado a servicio de urgencias HSR. Evaluado por neurología con episodios de apnea, sopor medio a profundo, movilizándolo extremidades, M4 hemicuerpo derecho y aprox M2 HC izquierdo, plantares flexores. Se realizó prueba de naloxona sin respuesta, se cargó con PHT 1.5 g, y se procedió a IOT. TC de cerebro de ingreso muestra múltiples focos de pequeñas hemorragias hemisféricas derechas. Evaluado por neurocirugía, sin indicación qx urgente. Se realiza EEG, sin actividad epileptiforme. De todas formas se mantienen FAEs. Por otro lado se inicia Amp/Sulbactam empíricos por sospecha de neumonía aspirativa por parámetros inflamatorios elevados. Se inicia superficialización de sedación e ingresa a UPC para inicio de weaning ventilatorio.

Diagnósticos de ingreso UPC:

1)- Compromiso de consciencia en estudio

TEC severo complicado: Múltiples focos de pequeñas hemorragias hemisféricas derecha

Sospecha Intoxicación por uso de sustancias

EEG: actividad lenta generalizada

2) Neumonía aspirativa en tratamiento

-Antecedentes: TUS policonsumo, autoagresiones, antecedente de Craniectomía derecha descompresiva (TEC severo complicado febrero 2022)

Evolución por planes en UPC:

Fecha Epicrisis : 22/12/2022 09:29

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 22-12-2022 9:29:49

Página 2 de 3

HDN: se logran suspender DVA logrando normotensión. No fue conflicto.

Neurología/Neurocirugía: Paciente hospitalizado por compromiso de conciencia, se interpreta secundario a hemorragias corticales múltiples, pero sin claridad de la causa de estas hemorragias corticales (sospecha de TEC). EEG sin AEI ni crisis. Se mantuvo con fenitoína y ácido valproico. Último TAC 18/11 sin complicaciones agudas.

Psiquiátrico: Evoluciona con gran agitación, se mantuvo con diazepam, precedex y risdperidona que posteriormente se cambia a olanzapina, con respuesta parcial.

Respiratorio: ingresa intubado en contexto de compromiso de conciencia. Sedoanalgesia con Dexmedetomidina. Se extuba el 17/11 pese a agitación psicomotora importante. Evoluciona sin requerimientos de O2. Sin conflicto.

Infeccioso: Cursa con 7 días de amp/sulb empírico por sospecha de neumonía aspirativa. No fue conflicto.

Medio interno: Sin alteraciones hidroelectrolíticas ni falla renal.

Se traslada a UTAC

Evolución en UTAC

Hemodinamia: estable.

Neuroquirúrgico: TEC grave febrero 2022 que requirió craniectomía descompresiva. Ahora con nuevo episodio de TEC complicado con múltiples focos de pequeñas hemorragias hemisféricas derecha. Evoluciona con importante agitación psicomotora dado síndrome de abstinencia.

- 28/11 compromiso de conciencia que mejora al suspender BDZ. Evaluado por psiq el 7/12, reinician.

- 01/12 se realizó cranioplastía con hueso autólogo, evolucionó con HEC temporoparietal derecho que requirió evacuación. TC 2/12 evaluado x ncx: evacuación satisfactoria con recuperación de línea media.

- 05/12 se retiró drenaje JP subgaleal x ncx.

- Último TAC 6/12 ev x neurocx sin complicaciones.

Neurológico: epilepsia secundaria a TEC febrero 2022, usuario crónico A. Valproico (nula adherencia). EEG de ingreso sin actividad epileptiforme. Se mantuvo con terapia de base, pero dado HEC se agregó PHT como profilaxis antconvulsivante. Control 7 /12 de NP fenitoína ajustado por albumina bajos, se suspende.

Mantiene solo Ac Valproico.

Rehabilitación: Kinesioterapia motora activa. FNA sin conflicto actual.

Psiquiatría: Policonsumo hace 15 años principalmente pasta base, pero también cocaína, OH, éxtasis, ketamina, clonazepam, marihuana, tussi. Completó carga de tiamina en UPC. Cursó con agitación, precedex suspendido el 24/11.

Evaluado inicialmente por PEMP sugieren: suspender olanzapina, dejar diazepam 10-10-20 y haldol horario. Comentan que NO tiene indicación de institucionalización en dispositivo de salud mental, por lo que debe ser evaluado por asistente social.

BZD suspendidas el 27/11 por impregnación farmacológica (compromiso de conciencia y bradipsiquia que mejoró al suspender BZD).

Por cuadro de agitación es reevaluado por PEMP a quienes les impresiona paciente con síntomas catatónicos. Sugieren iniciar Lorazepam 2-2, ajustan dosis de haloperidol 5 mg c/12 hr (ECG QT en 440) y solicitan exs generales (normales) que incluyan amonio (rechazado)

Solicito amonio para mañana AM.

Infeccioso: cursó con 7 días de ampi/sulbactam por sospecha de NAC aspirativa. Ahora no es conflicto.

Respiratorio: Cursó con TOT; extubado el 17/11. Actualmente estable.

Profilaxis: Se mantiene profilaxis de UPP, sin tromboprofilaxis de momento, definir con neurocx.

Fecha Epicrisis : 22/12/2022 09:29

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:29

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 22-12-2022 9:29:49

Página 3 de 3

Social: paciente con antecedentes penales, con orden de alejamiento de algunos familiares. En evaluación por asistente social.

Manejo: activo. Eventual traslado a hospital de rehabilitación para manejo de sd de abstinencia.

Traslado a sala básica de neurocirugía

Evoluciona en forma favorable. Con algunos episodios de agitación, con buena respuesta a haloperidol + Lorazepam VO en horario. Kine: buen control de tronco, marcha con carrito anterior. Tolerando bien vía oral, sin SNG. Se conversa caso con Asistente social, madre lo recibirá en casa y lo llevará en forma ambulatoria a centro de rehabilitación

Diagnóstico de Egreso

Convulsiones No Clasificadas En Otra Parte -
Traumatismo Intracraneal -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

vigil, orientado, isocoria reactiva.
M3 ESI, resto al menos M4

Plan Post Alta

- Reposo relativo
- Régimen liviano
- Haloperidol 5 mg c/8h VO
- Lorazepam 2 mg SOS (manejar por madre)
- Ac valproico 500 mg c/12 hrs VO
- Control ambulatorio con Neurocirugía en 1 mes, pedir hora en CDT con epicrisis
- Asistir en forma ambulatoria a terapia kinesiológica en centro de rehabilitación (acompañado de madre)
- Consulta SOS en caso de signos de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Felipe Andrés Cifuentes Fernández
Becado/Residente



Jaime Monsalve Rosales
Médico Tratante (Staff)